Modulo formativo 0249_2: HIGIENE Y ATENCIÓN SANITARIA DOMICILIARIA

1. MOVILIDAD DE LA PERSONA DEPENDIENTE

1.1 PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DE SOSTÉN Y MOVIMIENTO DEL CUERPO HUMANO.

El cuerpo humano se compone de distintos órganos que pueden ser agrupados en sistemas según su similitud o función. Uno de ellos es el sistema osteomuscular, que se compone de huesos, músculos y articulaciones. Cualquier alteración de las partes que lo componen puede crear graves alteraciones al afectar a la capacidad de sostén y movimiento de la persona. El problema más frecuente es el de las inmovilizaciones de miembros.
El profesional debe conocer la estructura del aparato locomotor para poder cumplir de forma correcta su función.

El esqueleto humano es:

- SOSTÉN mecánico del cuerpo y de sus partes blandas, funcionando como un armazón que mantiene la morfología, a la vez que PROTEGE las vísceras y permite la realización de diversas posturas como la bipedestación.
- SOPORTE DINÁMICO, permite el movimiento en sus diversas formas actuando como palancas y puntos de anclaje para los músculos.
- ALMACEN METABÓLICO, moderando la relación de sales de calcio y fosfatos,
- CONTENEDOR DE MEDULA ÓSEA.

1.2 APARATO LOCOMOTOR.

El aparato locomotor permite al ser humano interactuar con el medio que le rodea mediante el movimiento o locomoción.

Se fundamenta en tres elementos:

- Huesos,
- Articulaciones y
- Músculos.

El aparato locomotor no es independiente ni autónomo, pues es un conjunto integrado con diversos sistemas, por ejemplo, con el sistema nervioso para la generación y modulación de las órdenes motoras. Este sistema está formado por las

estructuras encargadas de sostener y originar los movimientos del cuerpo y lo constituyen dos sistemas.

1.2.1- SISTEMA ÓSEO

Los huesos has sido clasificados según distintos criterios, en función se sus dimensiones y en función de su forma. Es el elemento pasivo, está formado por los huesos, los cartílagos y los ligamentos articulares. Una forma de clasificación:

1. Según tamaño se han agrupado en:
a. Largos
b. Cortos
c. Anchos o planos.

2. Según morfología se les ha clasificado en huesos:
a. Radiados
b. Arqueados
c. Papiráceos (formados por laminillas de tejido óseo.)

El esqueleto humano está formado por más de 200 huesos que se unen por bandas de tejido conjuntivo resistente y poco elástico denominados ligamentos. Las distintas partes del cuerpo varían mucho en su grado de movilidad.

Los movimientos de los huesos del esqueleto se llevan a cabo gracias a las contracciones de los músculos esqueléticos que se unen a los huesos a través de tendones. Estas contracciones musculares están controladas por el sistema nervioso.

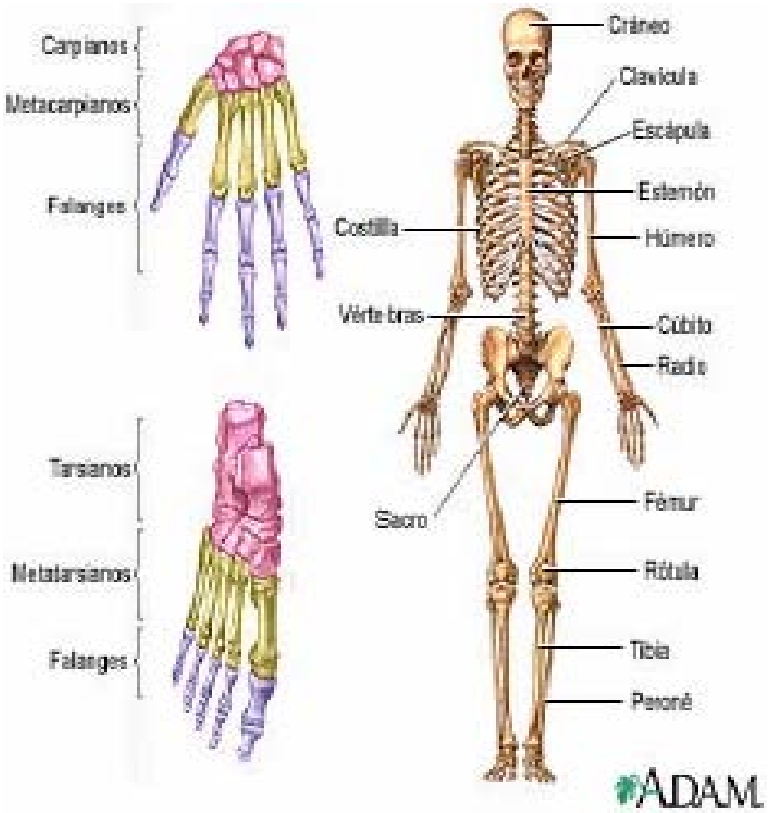
Diferenciamos:

- Esqueleto axial: cráneo, columna vertebral y las costillas.
- Esqueleto apendicular: formado por la cintura pélvica y escapular y las extremidades.

Funciones:

- Actúan como palancas óseas para favorecer los movimientos de las articulaciones, en el caso de las articulaciones provistas de movilidad.
- Constituyen un armazón sólido y resistente que amortigua las fuerzas que actúan sobre el cuerpo (gravedad, choques, golpes…)
- Forman estuches o cajas que protegen los órganos vitales (cavidad torácica-corazón, cavidad craneal-cerebro…)
- El tejido óseo (médula ósea) es responsable de la producción de la sangre (hematopoyesis)

- Constituyen un lugar para el depósito de sales de calcio y fósforo, participando en su metabolismo.
- Participa en su formación y reabsorción ósea.



1.2.2. LAS ARTICULACIONES

La unión entre dos o más huesos constituye las articulaciones. Posibilitando desplazamiento y manteniendo la estabilidad adecuada. En función del tipo de movimiento que se produzca, se pueden distinguir tres tipos de articulaciones:

- Sinartrosis o de articulaciones sin movimiento. Es la unión entre huesos que no implica ningún tipo de movilidad, como ocurre con los huesos del cráneo.
- Anfiartrosis. Es el tipo de articulación que permite algo de movimiento pero muy limitado, como ocurre con las vértebras.
- Diartrosis o articulaciones sinoviales. Son aquellas que permiten gran variedad de movimientos, por ejemplo, el codo o la rodilla.

Partes de una articulación:

- Superficies articulares: son los extremos óseos recubiertos por un cartílago articular.
- Ligamentos articulares:
- Líquido articular o líquido sinovial: sirve de amortiguación a la articulación.
- Cápsula articular: sujeta la articulación.

- Meniscos: pueden estar presentes ó no.

No todas las articulaciones permiten igual movilidad y en función de qué tipo de movimientos permiten (desplazamientos laterales, anterior, posterior, rotación etc.) se denominan de diferente manera:

Así, las articulaciones entre los huesos del cráneo permiten nulo movimiento a diferencia de la articulación de la cadera.

1.2.3- SISTEMA MUSCULAR

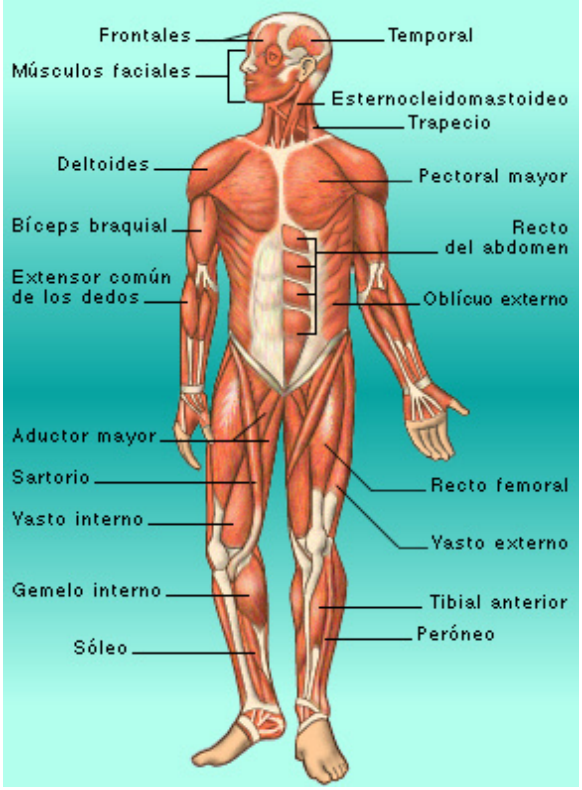
Es el conjunto de los más de 650 músculos del cuerpo y el 42% del peso corporal total en un adulto sano y joven, cuya función primordial es generar movimiento, ya sea voluntario o involuntario -músculos esqueléticos y viscerales, respectivamente.

El sistema muscular permite que el esqueleto se mueva, mantenga su estabilidad y la forma del cuerpo. En los vertebrados se controla a través del sistema nervioso, aunque algunos músculos (tales como el cardíaco) pueden funcionar en forma autónoma.

Aproximadamente el 40% del cuerpo humano está formado por músculos, vale decir que por cada kg de peso total, 400 g corresponden a tejido muscular.

El sistema muscular es responsable de:

- Locomoción: efectuar el desplazamiento de la sangre y el movimiento de las extremidades.
- Actividad motora de los órganos internos: el sistema muscular es el encargado de hacer que todos nuestros órganos desempeñen sus funciones, ayudando a otros sistemas como por ejemplo al sistema cardiovascular.
- Información del estado fisiológico: por ejemplo, un cólico renal provoca contracciones fuertes del músculo liso generando un fuerte dolor, signo del propio cólico.
- Mímica: el conjunto de las acciones faciales, también conocidas como gestos, que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos.
- Estabilidad: los músculos conjuntamente con los huesos permiten al cuerpo mantenerse estable, mientras permanece en estado de actividad.
- Postura: el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo.
- Producción de calor: al producir contracciones musculares se origina energía calórica.
- Forma: los músculos y tendones dan el aspecto típico del cuerpo.
- Protección: el sistema muscular sirve como protección para el buen funcionamiento del sistema digestivo como para los órganos vitales.



1.3 PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES DEL APARATO LOCOMOTOR.

- Osteoporosis: consiste en la descalcificación de los huesos que provoca que éstos se vuelvan porosos y por tanto más frágiles y susceptibles a las fracturas.
- Fractura ósea: consiste en la pérdida de continuidad de la superficie del hueso. Se produce normalmente como consecuencia de un traumatismo directo.
- Hernia discal: es una patología de las vértebras de la columna vertebral que consiste en la deslocalización del disco intervertebral.
- Lumbalgia: consiste en el dolor agudo o crónico en la espalda. El tratamiento consiste en reposo, calor local seco, analgésicos y en algunos casos bajo prescripción médica antiinflamatorios. Un ejemplo es la lumbociática que se produce cuando una vértebra lumbar comprime el nervio ciático y el dolor se irradia hacia las extremidades inferiores.
- Esguince: consiste en la distensión o estiramiento de un ligamento que cuando es muy grave puede llegar a romperse total o parcialmente. Es una patología dolorosa que origina inflamación e impotencia funcional.

- Artrosis: se caracteriza por el desgaste del cartílago que hay entre las articulaciones y por la inflamación. El desgaste se produce generalmente por la edad. Es más frecuente en los ancianos.
- Artritis: inflamación de la articulación y deriva de múltiples causas como traumatismos, infecciones o enfermedades propias de las articulaciones producidas por desgaste como la artrosis.
- Gota: inflamación de las articulaciones debido a los depósitos de ácido úrico en forma de cristales dentro de la articulación.

1.4 BIOMECÁNICA DE LAS ARTICULACIONES.

Las superficies de contacto entre dos huesos próximos se denominan articulaciones. El concepto de la palabra biomecánica (combinación de las palabras biología y mecánica) tiene que ver con los principios y métodos de la mecánica aplicados al estudio de la estructura y función de sistemas biológicos.
Cada articulación está especializada en determinadas funciones, que pueden ir desde una ausencia total de movilidad, siendo su función principal el cierre mecánico de una cavidad (función protectora), o bien provista de una gran movilidad y actuar de palanca ósea (la rodilla)

La biomecánica analiza las funciones articulares, musculares y fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo e integra las leyes de la mecánica en los movimientos humanos. Las investigaciones en este ámbito, se realizan en movimientos que el individuo desempeña durante la vida diaria, en los lugares de trabajo y en la actividad física como la marcha o las diferentes especialidades deportivas.

Las aplicaciones de las investigaciones del movimiento del cuerpo humano son dirigidas, entre otras, a la comprensión y depuración de las técnicas deportivas, y al estudio de la marcha normal y patológica (ocasionada por diferentes patologías tanto neurológicas como músculo-esqueléticas) con fines diagnósticos y de rehabilitación. Las partes del cuerpo humano se consideran estructuras o cuerpos rígidos para facilitar el estudio del movimiento.

Los movimientos se miden en tres dimensiones con relación a los planos anatómicos estándar: sagital, frontal y transversal. Anidados a esta referencia, se usan sistemas de ejes cartesianos (x, y, z). Los sistemas modernos de análisis del movimiento en 3 dimensiones (3D) con plataformas de fuerza ofrecen la posibilidad de obtener datos objetivos cinemáticos (movimientos) y, lo que es de sumo interés, cinéticos (momentos de fuerza y potencias) de todas las articulaciones.

Estos datos son de gran utilidad para describir mecanismos íntimos que subyacen en las alteraciones de la marcha y en las articulaciones relacionadas. En efecto, disponer de información sobre las fuerzas que se generan en cada momento en las diferentes articulaciones permite establecer de una manera precisa qué papel tienen los elementos activos (músculos con sus hiperactividades y debilidades) y pasivos

(tendones, huesos, ligamentos, cápsulas articulares y músculos con relación a acortamientos o laxitudes) en las alteraciones de la marcha y otras patologías articulares.

2. EMPLEO DE TÉCNICAS DE MOVILIZACIÓN, TRASLADO Y DEAMBULACIÓN

2.1 POSICIONES ANATÓMICAS.

Los cambios frecuentes de postura en los usuarios encamados tienen como finalidad:

- Evitar la aparición de isquemia en los llamados puntos de presión, debido a la acción de la gravedad y al propio peso.
- Evitar que la ropa que cubre la cama roce la piel y llegue a producir lesiones.
- Prevenir la aparición de úlceras por presión.
- Proporcionar comodidad al usuario.

Para ellos debemos cuidar:

- ❖ Que las sábanas estén bien limpias, secas y estiradas.
- ❖ Las zonas de mayor presión corporal estén protegidas.
- ❖ Las piernas estén estiradas y los pies formen ángulo recto con el plano de la cama.

Utilizaremos para los cambios posturales los siguientes materiales:

- o Almohadas y cojines.
- o Férulas.
- o Ropa limpia para cambiar la cama.
- o Protectores de protuberancias si fueran necesarios.

LAS POSICIONES BÁSICAS

Las posiciones básicas que adopta el paciente en la cama son:

- Posición de decúbito supino, o dorsal o posición anatómica
- Posición de decúbito lateral izquierdo o derecho
- Posición de decúbito prono

Posición de decúbito supino (boca arriba)

- Es la posición que se emplea con mayor frecuencia.



Posición de decúbito lateral (derecho o izquierdo)
Se utiliza en los siguientes casos:

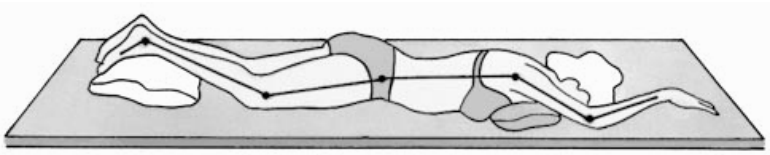


- Cambios posturales
- Higiene corporal
- Descanso
- Cambio de ropa de cama con paciente encamado



Posición de decúbito prono- boca abajo
Se utiliza en los siguientes casos:

- En pacientes con cirugía dorsal
- Para realizar masajes en la espalda
- Para cambios posturales



LAS POSICIONES ESPECIALES

Según las circunstancias el paciente puede adoptar otras posturas durante su permanencia en la cama.
Estas posturas son:

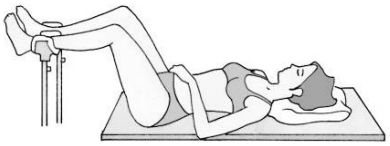
- Posición Fowler
- Posición ginecológica
- Posición de litotomía dorsal
- Posición genupectoral
- Posición de Sims
- Posición de Trendelenburg
- Posición de Antitrendelenburg
- Posición de Roser

Posición de Fowler



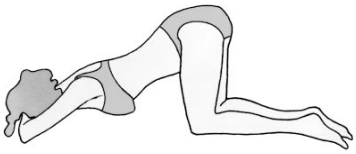
Posición ginecológica
El paciente se encuentra en decúbito supino, las rodillas separadas y flexionadas y los pies apoyados sobre la cama.

Se utiliza principalmente en:



- El lavado de genitales en la mujer
- El sondaje vesical en la mujer
- El examen de la pelvis
- La exploración de las mujeres embarazadas

Posición genupectoral
Esta posición es adecuada para exploraciones rectales.



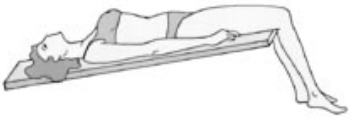
Posición de Sims (posición lateral de seguridad)
Esta posición es recomendable en:



- Pacientes inconscientes
- En la colocación de sondas rectales En la administración de enemas
- En exámenes rectales

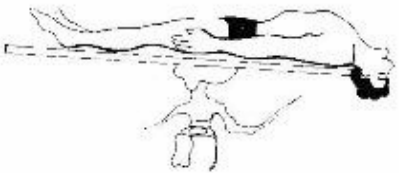
Posición de Antitrendelenburg
Está indicada en pacientes con problemas respiratorios, hernia de hiato, etc.

Posición de Trendelenburg
Se utiliza en:



- Tratamiento quirúrgico de los órganos pelvianos
- Ante lipotimias
- Situaciones que requieran un buen aporte sanguíneo cerebral

Posición de Roser
Se utiliza en los siguientes casos:



- Lavado de pelo del paciente encamado

- En determinadas intervenciones quirúrgicas

2.2 TÉCNICAS Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA DEAMBULACIÓN, TRASLADO Y MOVILIZACIÓN EN PERSONAS DEPENDIENTES

La inmovilidad deteriora de manera significativa la calidad de vida de las personas dependientes, especialmente de los adultos mayores. No podemos considerar normal o inevitable que los dependientes con el paso de los años, acaben inmovilizados. En términos generales, debemos diferenciar entre dos tipos:

- Una inmovilidad relativa, en la que el usuario lleva una vida sedentaria pero es capaz de movilizarse en menor o mayor independencia.
- Una inmovilidad absoluta que implica el encadenamiento crónico, estando muy limitada la variabilidad postural.

¿Qué causas pueden ocasionar inmovilización?

- La causa principal es el encamamiento tras enfermedades agudas y sobre todo tras hospitalizaciones.
- Enfermedades reumatológicas, por el dolor y la deformidad articular.
- Accidente cerebrovascular (ictus o infarto cerebral.)
- Enfermedad de Parkinson y otras demencias en fases avanzadas.
- Neuropatías periféricas, sobre todo en diabéticos.
- Enfermedades cardiacas y respiratorias que van limitando progresivamente la resistencia al ejercicio.
- Mala nutrición.
- Trastornos de la marcha, vértigo posicional, síndrome postcaída.
- Exceso de peso.
- Falta de motivación o estados depresivos.
- Apoyo social insuficiente o falta de información sobre cómo debe reiniciarse la movilización y qué ayudas técnicas son necesarias.
- Muchos fármacos aceleran la inmovilidad por sus efectos secundarios como la hipotensión ortostática o deterioro del nivel de consciencia.
- Problemas en los pies: callosidades, trastornos de las uñas y deformidades que causan dolor y alteración de la marcha.
- Muchos dependientes alargan voluntariamente las horas de sueño aumentando el riesgo de acabar encamado.

Existen múltiples técnicas de movilización que requieren tener en cuenta unas Normas generales para la movilización

- Separar los pies, uno al lado del objeto y otro detrás; girar el pie más próximo en la dirección hacia la que nos desplazamos.
- A partir de la posición de agachados (posición de sentados), mantener la espalda derecha (que no siempre es vertical);
- Una espalda derecha hace que la espina dorsal, los músculos y los órganos abdominales estén en alineamiento correcto;
- Se minimiza la comprensión intestinal que causa hernias;

- Cuello y cabeza deben seguir la alineación de la espalda;
- Dedos y manos han de extenderse por el objeto para ser levantados con la palma. Los dedos solos, tienen poca potencia;
- Acercarse al objeto, brazos y codos al lado del cuerpo. Si los brazos están extendidos, pierden mucha de su fuerza. El peso del cuerpo está concentrado sobre los pies. Comenzar el levantamiento con un empuje del pie trasero;

Las ayudas técnicas son cualquier objeto, equipo o producto utilizado para aumentar, mantener o mejorar las habilidades de las personas con discapacidad, de tal forma que promueven la independencia en todos los aspectos de la vida diaria de la persona. Reconocen las desigualdades en las que se encuentran las personas con discapacidad, por lo que procuran compensar o equiparar oportunidades. Debido a la naturaleza dinámica de las personas, pueden variar en el transcurso de la vida de la persona y según el entorno.

Para el desplazamiento y la movilización tenemos entre otras:

• Muletas con codo: No siempre dan sensación de seguridad



• Bastón: se colocará en el brazo contrario de la pierna afectada, aumentando la sustentación. Se deben usar ligeramente adelantado y paralelo al cuerpo. Tienen la puntera de goma con fin antideslizante. La altura del bastón debe ser la que consiga que la mano esté a la altura de las caderas con el codo ligeramente doblado y los hombros al mismo nivel.



• Trípode y bastones de cuatro patas: Son más estables y se indican en personas de mayor inestabilidad.



• Andadores: Pueden ser sin ruedas o con ellas. Requieren tener fuerza en las dos manos y acercarse a ellos pues si no aumenta el riesgo a caidas. Están indicados en fases agudas e inestabilidad elevada. La altura habitual es de unos 80 cm y los codos deben estar un poco doblados con las patas traseras del andador a la altura de los pies del usuario.





- Silla de ruedas: Diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión, enfermedad física (paraplejía, tetraplejía, etc) o psicológica.
    - Tipos:
        - Electrica 
        - Manual



• Grúa: Se utilizan para realizar las transferencias de los pacientes cuando el nivel de dependencia es muy alto, hay diversos tipos.





2.3 TÉCNICAS PARA EL POSICIONAMIENTO EN CAMA.

Los cambios posturales son las modificaciones realizadas en la postura corporal del paciente encamado. Para realizar estos cambios se deben seguir unas normas generales tales como:

- Preparar el área donde se va a trabajar, quitando aquellos elementos que puedan entorpecernos.
- Procurar realizar el esfuerzo con los músculos mayores y más fuertes (muslos y piernas).
- Acercarnos lo máximo posible a la cama del enfermo para que el esfuerzo sea menor, y la columna vertebral debe estar erguida.
- Es preferible deslizar y empujar, que levantar.
- Cuando sea posible, debe actuar más de una persona.

Incorporar al usuario:

- Indique al usuario que ponga sus brazos a los lados con las palmas de las manos sobre la cama. Así el usuario puede empujar para proporcionar fuerza adicional.
- Mirando hacia la cabecera, el profesional se sitúa a un lado de la cama a la altura de la cadera del usuario. El profesional debe buscar una base de apoyo amplia, con el pie más alejado hacia delante, y el peso del cuerpo sobre el pie.
- El profesional coloca su brazo más alejado sobre el hombro más alejado del usuario. El profesional debe poner su mano libre sobre la cama, cerca del otro hombro del usuario, úselo para empujar durante el levantamiento.
- Tirando con un brazo y empujando con el otro, levante el usuario, a la vez que cambia el peso de pie. A su vez, el usuario empujará con sus manos (si es posible.)
- Cuando sea posible, debe actuar más de una persona.

Movimiento del usuario a la orilla de la cama:

- Frenaremos la cama (si dispone de cama articulada) y la colocaremos en posición horizontal (sin angulación) retiraremos las almohadas y destaparemos al usuario.
- Nos colocaremos en el lado de la cama hacia el que queremos desplazar al usuario, y colocaremos el brazo más próximo del usuario sobre su tórax.
- Pasaremos nuestro brazo bajo la cabeza y cuello hasta agarrar el hombro más lejano y, con el otro brazo, cogeremos, bajo su cuerpo, la zona lumbar.
- Una vez trabado con ambos brazos, tiraremos simultánea y suavemente del usuario hacia la orilla de la cama.
- Una vez desplazada esta parte del cuerpo, situaremos uno de nuestros brazos bajo los glúteos y el otro bajo el tercio inferior de los mismos y procederemos a desplazar al usuario hacia la orilla de la cama.

Sentar al usuario en el borde de la cama:

- El auxiliar adelanta un brazo, el más próximo a la cabecera, y rodea los hombros del enfermo, y el otro lo coloca en la cadera más lejana del enfermo (también puede situarse por debajo de los muslos, sujetando la pierna distal.)
- Con esta mano hace que la cadera y las piernas giren de modo que queden colgando del borde de la cama, y con el otro brazo ayuda a erguir el tronco. Estos pasos deben realizarse en un solo movimiento.

Enseñanza al usuario a sentarse en la cama solo sin ayuda:

- Los usuarios que por procesos agudos se pueden sentar solos, sin necesidad de asistencia, deberán recibir la educación correcta por nuestra parte. El profesional debe indicarle que realice los siguientes pasos:
  - Rodar hacia un lado y levantar la pierna más alejada sobre la otra.

- Agarrar el borde del colchón con el brazo inferior y empujar con el puño del brazo superior dentro del colchón.
- Empujar con los brazos mientras se deslizan los talones y las piernas sobre el borde del colchón.
- Mantener la posición de sentado empujando con ambos puños dentro del colchón por detrás y a los lados de las nalgas.

Subir al usuario hacia la cama:

- Si el usuario coopera, le retiraremos la almohada con cuidado.
- Con el usuario acostado, le diremos que flexione las rodillas, apoyando ambos pies en la cama, y le pediremos que se agarre al cabecero de la misma con ambas manos.
- Le pasaremos el brazo más cercano al usuario por debajo de la espalda a la altura de los hombros, sujetándole el hombro más alejado de nosotros, y el otro brazo se le pasará por debajo de los muslos.
- Una vez preparados, indicaremos al usuario que realice fuerza hacia arriba, ayudándose de sus manos agarradas al cabecero, y de sus piernas apoyadas el colchón, a la vez que nosotros colaboramos en el movimiento, hasta que quede bien colocado.
- Le colocamos la almohada y arreglamos la ropa de la cama.
- Si el usuario no colabora, se pierde realizar el movimiento con la sábana entremetida, pero es necesaria la actuación de dos personas. Otra posibilidad entre dos personas en movilización es sujetando cada una de ellas un hombro y un muslo, situamos ambos a cada lado de la cama. Vigilar en ambos casos la posición corporal mientras se realiza la técnica, utilizando como fuerza motriz las piernas, iniciando el movimiento con las rodillas flexionadas y con el pie más cerca no al cabecero mirando en dirección al movimiento y manteniendo la espalda recta.

2.4 ORIENTACIÓN A LA PERSONA DEPENDIENTE Y A SUS CUIDADORES PRINCIPALES.

La inmovilidad es un problema sanitario muy importante en las personas dependientes. Los cuidados ante problemas de movilidad dependen, por una parte, del usuario, su estado general y mental y, por otra, de su familia y entorno. Es fundamental intentar mantener las capacidades funcionales del usuario, evitar posibles complicaciones y logar una adecuada calidad de vida. Tanto a la persona dependiente como a sus cuidadores se les debe instruir en las diferentes técnicas de movilización, cuidados…. para facilitar por un lado la autonomía del usuario y por otro el trabajo del cuidador.

La persona dependiente, en la medida de sus posibilidades, debe ser consciente de sus limitaciones para poder participar y colaborar en las diversas técnicas aprendidas, por otro lado el cuidador principal debe asumir los cambios que se van

a producir en su vida diaria y la necesidad de formación en este nuevo área, en caso de no tenerla y la necesidad de apoyo y ayuda.

El conocimiento de las diversas técnicas de movilización y transferencias, así como el uso adecuado de las ayudas técnicas y el conocimiento de las existentes en el mercado facilitará el uso de las mismas.
Con respecto a las recomendaciones y cuidados específicos del usuario con problemas de movilidad, señalaremos cuatro fundamentales:

- actividad y capacidad funcional
- cuidado de la piel
- la alimentación
- la eliminación

Actividad y Capacidad funcional:

- Actividades físicas: el usuario debe levantarse a diario, si no es capaz de caminar, debe levantarse a una silla; y sólo en casos de suma necesidad permanecer en cama día y noche. Siempre que pueda debe colaborar en su cuidado personal: aseo, alimentación y vestuario. Para mantener el tono físico, el usuario debe realizar flexiones y extensiones de las extremidades y del tronco, y evitar la tendencia a encorvarse. Mediante actividades como coger y lanzar una pelota, estando sentado extender y levantar las piernas… apoyar las manos haciendo fuerza y levantar las nalgas.
  Es importante realizar cambios posturales cada dos horas para evitar la formación de escaras. También debemos evitar el denominado pie equino (pie caído) usando un apoyo que lo mantenga en 90º. Si tras varios días en cama comienza a levantarse es necesario hacerlo de un modo paulatino. Debemos fomentar el movimiento del usuario siempre que no exista contraindicación médica, siendo fundamental implicar al usuario y a la familia en los procesos de recuperación.

- Actividad mental: el usuario debe usar la memoria, imaginación y el lenguaje; esto favorecerá el estado anímico y su capacidad mental. Para la memoria es útil repasar sucesos de su vida con fotos, noticias del día… La imaginación se puede ejercitar si se le pregunta qué espera del día, cómo solucionar algún problema…las preguntas deben tener un acento optimista. También usar juegos como el dominó, cartas, juegos de memoria o de atención.

- Cuidados de la piel: especial cuidado en usuarios encamados por estar expuestos a importantes problemas como escaras o infecciones.

- Nutrición: Las personas con movilidad reducida pueden sentir poca sed y se deshidratan con facilidad. Si es posible, con el usuario sentado debe administrarse en pequeñas cantidades cada vez, la cantidad diaria debe fluctuar entre 1´5 y 2 litros, incluyendo el líquido de las comidas. Puede restringirse después de cenar para disminuir

la orina durante la noche. Si se alimenta por la boca es importante la buena presentación y el sabor, la administración debe ir precedida y seguida de aseo oral y de las manos y siempre que sea posible, el usuario debe estar sentado.

- Eliminación: El usuario con problemas de movilidad puede sufrir incontinencia de orina o deposiciones, con maceración e infecciones en la piel. También es habitual que aparezca estreñimiento y retención de orina con molestias e infecciones urinarias. Debemos intentar que defeque a diario comiendo fibra y si es pautado por el médico, podrá tomar laxantes. En caso de incontinencia de orina se consultará con el médico para pautar las mejores posibilidades terapéuticas para cada caso, así como para retención de orina.

2.5 FOMENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA PERSONA DEPENDIENTE Y SU ENTORNO PARA LA MEJORA DE SU MOVILIDAD Y ESTADO FÍSICO.

El cuidado y la ayuda pueden generar en ocasiones una mayor dependencia. Es necesario mejorar el ambiente físico y social para disminuir esta situación.

Un ambiente físico estimulante, con suficientes ayudas protésicas que conjuguen de manera adecuada la autonomía con la seguridad, contribuye a que las personas mayores tengan un funcionamiento óptimo en sus tareas cotidianas. En este sentido, la adaptación de la vivienda a las características de la persona mayor adquiere una gran relevancia.

El ambiente social puede favorecer o prevenir la dependencia. Las actitudes y la forma de comportarse de los familiares y el entorno social más próximo ante el deterioro de la salud de las personas de edad avanzada influyen en el grado de autonomía e independencia que muestran.

Las conductas de los familiares que pueden agudizar la dependencia son las siguientes:

- Con el fin de ayudar a la persona mayor en sus problemas de autonomía, los familiares acometen en ocasiones distintas tareas por ellos. En principio, esta situación es positiva. Sin embargo, no lo es tanto cuando esta sustitución se produce en actividades en las que aún pueden valerse por sí mismos, aunque sea de manera parcial. Por ejemplo, así ocurre cuando la persona mayor puede vestirse, aunque con lentitud y dificultad, y el cuidador lo hace por él o ella para evitarle complicaciones. De este modo no se le da la oportunidad de demostrar su independencia en esta tarea y si este hecho

ocurre con frecuencia, es posible que acabe perdiendo esa habilidad por desuso.

- Cuando las personas mayores se consideran independientes para realizar alguna actividad y se valen de sus propios medios, los cuidadores a veces les amonestan o critican por haberse comportado así. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el cuidador está realizando otra tarea y la persona mayor se levanta sin ayuda para cambiar de asiento. El cuidador vuelve, se da cuenta y le recrimina por no haberle llamado para que le ayude. En este caso ocurre lo mismo que en el anterior, en el que si bien los familiares "regañan" a los mayores con cariño y lo hacen por su bien, al mismo tiempo impiden que mantengan su grado de independencia.
- Es habitual que cuando la persona mayor se desenvuelve con autonomía en tareas como vestirse, recoger su habitación, etc. y no demanda ayuda de los demás, suele pasar desapercibida y se ignora su comportamiento autónomo. No se reconoce su esfuerzo. Es frecuente que las conductas que no tienen consecuencias positivas, como ese reconocimiento o elogio de los demás, dejen de realizarse.

En resumen, cuando los cuidadores tienen la presunción de que sus familiares de edad avanzada no son capaces de realizar alguna actividad o de mejorar en algo, es posible que acaben prestando a su familiar más ayuda de la que en realidad necesitan. De esta forma, se priva a la persona mayor de practicar comportamientos o actividades para las que está capacitado. Esta limitación llevará a que esta capacidad se vaya perdiendo por falta de práctica. Este proceso provoca que las creencias iniciales de los cuidadores acerca de la incapacidad de los mayores para realizar alguna actividad acaben siendo realidades (la profecía que se autocumple).

Es necesario que la familia o la persona cuidadora tenga siempre en cuenta que cuidar significa ayudar sólo lo necesario.

3. TOMA DE CONSTANTES VITALES

Las constantes vitales son parámetros corporales que varían cuando el organismo NO funciona correctamente.

Las constantes vitales son:

- Temperatura
- Pulso
- Tensión Arterial

- Frecuencia respiratoria

SIGNOS VITALES	VALORES PROMEDIOS	INSTRUMENTOS DE MEDIDA
TEMPERATURA		
En axila o ingle	*36,5 – 37ºC*	**Termómetro** *(de vídrio, electrónico o de papel o plástico)*
En boca	*36,8 – 37,2 ºC*	
En recto	*37 – 37,7 ºC*	
PULSO	*70 – 80 latidos por minuto*	**Reloj con segundero**
RESPIRACIÓN	*15 – 20 por minuto*	**Reloj con segundero**
TENSIÓN ARTERIAL		
Sistólica	*Entre 120 – 140 milímetros de mercurio*	**Esfigmomanómetro** *(aneroide, de mercurio o electrónico)*
Diastólica	*Entre 70 – 85 milímetros de mercurio*	

3.1 TEMPERATURA.

Es la cantidad de calor del organismo, se mide en grados centígrados y oscila entre 36 y 37º C.
La temperatura no es un valor constante, suele variar en función de:

- Actividad física
- Hora del día
- La edad
- Temperatura ambiental.....

Las alteraciones de la temperatura pueden ser:

- Disminución o hipotermia (temperatura inferior a 35º C)
- Hipertermia o fiebre (temperatura superior a 37º C). Esta puede ser:
  - Febrícula (menor de 38ºC)
  - Fiebre ligera (38 – 38,5 ºC)
  - Fiebre moderada (38,5 – 39,5 ºC)
  - Fiebre alta (39,5 – 40,5 ºC)
  - Fiebre muy alta (temperatura superior a 40,5 ºC)

Para medir la temperatura se utiliza el termómetro. La medición puede realizarse en:

- Axila: es la más cómoda aunque la menos exacta.
- Boca: ***contraindicada*** en bebés y niños menores de 6 años; usuarios con patologías y cirugías orales o tienen dificultad para respirar por la nariz; usuarios inconscientes, usuarios que reciben oxígeno con mascarilla.
- Recto: Es la más exacta de las tres aunque la más incómoda, está indicada en niños menores de 6 años y en los enfermos inconscientes o confusos. Siempre teniendo que cuenta que no padezcan trastornos rectales, o en las extremidades inferiores.

Tipos de termómetros:

- Mercurio de cristal (para temperatura axilar, rectal y bucal),
- Timpánico
- Electrónico
- Químicos desechables.






3.2 FRECUENCIA RESPIRATORIA.

A la hora de analizar la respiración, además de la frecuencia podemos valorar: -Tipo de respiración. Valoramos si es normal, abdominal o costo-dia-fragmática.

-Simetría. Valoramos si ambos lados se mueven simétricamente.
-Ritmo. En ausencia de patología, la inspiración es más corta que la expiración, en proporción 1:3.
-Profundidad de la misma.
Se valorarán cuatro características:

• Frecuencia: Número de inspiraciones por minuto (12 – 16 rpm)
• Ritmo: Regularidad entre los movimientos inspiratorios y respiratorios
• Profundidad: Cantidad de aire que entra o sale con cada movimiento respiratorio.
• Simetría de los movimientos: consiste en la elevación y descenso de la caja torácica por igual.

En la medición de la frecuencia respiratoria, es importante que la persona no perciba que se le está observando los movimientos, puesto que puede variar el ritmo, frecuencia, y la profundidad, valorar el ritmo y características de la respiración, observar cualquier variación del ritmo respiratorio, observar signos de dificultad respiratoria.

3.3 PRESIÓN ARTERIAL.

La presión arterial (PA) o tensión arterial (TA) es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. Esta presión es imprescindible para que circule la sangre por los vasos sanguíneos y aporte el oxígeno y los nutrientes a todos los órganos del cuerpo para que puedan funcionar.

Se diferencian dos tipos:

- Sistólica: entre los 120 y 140 mm Hg y
- Diastólica entre los 70 y 90 mm Hg.

Para medir la TA se utiliza el esfigmomanómetro y el fonendoscopio.



Asegurar que el usuario se halla en reposo, realizar las mediciones siempre con el mismo esfigmomanómetro, el usuario debe estar sentado o tumbado.

1. Poner el brazo del usuario a la altura del corazón y que lo mantenga en reposo.
2. Poner el manguito sobre el brazo desnudo, justo por encima de la flexura del brazo.
3. Colocar la membrana del fonendo en la flexura del brazo, inmediatamente debajo del manguito.
4. Cerrar la válvula y bombear la pera hasta que se alcance una presión mayor de la posible esperada, 200 mm Hg aproximadamente.
5. Abrir la válvula, soltando lentamente el aire y escuchar atentamente.
    a. Cuando el latido sea audible, anote la presión, que es la TA máxima o sistólica que marca el manómetro. Seguir desinflando.
    b. Cuando el latido deja de oírse, anote de nuevo la presión, que es la TA mínima o diastólica.

3.4 FRECUENCIA CARDIACA.

Refleja el bombeo de la sangre desde el corazón hasta las arterias.

Las características del pulso son:

• Frecuencia: número de pulsaciones por minuto (60 y 80 ppm). Que depende de:

- Edad
- Ejercicio
- Temperatura
- Emociones

• Ritmo: es el tiempo de separación entre latidos. Puede ser:

- Rítmicos o regulares
- Arrítmicos o irregulares

• Intensidad: es la fuerza de la sangre en cada latido.

Alteraciones del pulso

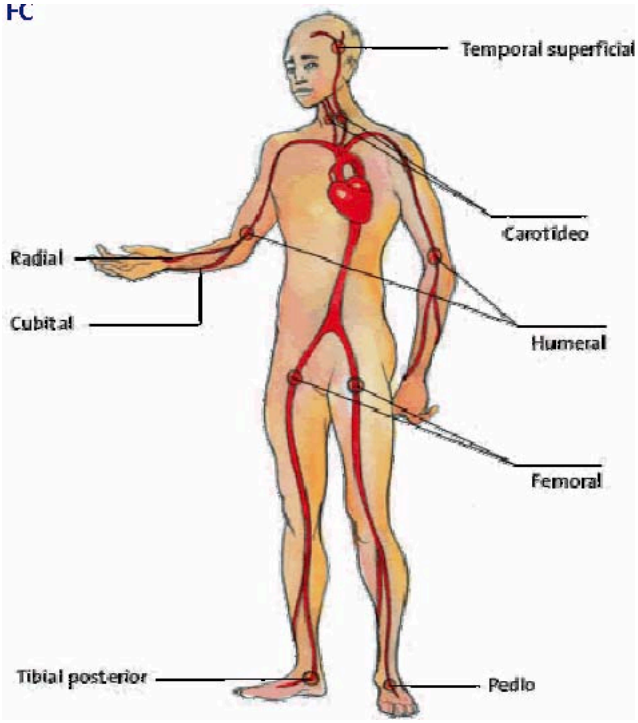
• Taquicardia: valores superiores indican aumento de la frecuencia cardiaca

• Bradicardia: valores inferiores indican descenso de la frecuencia cardiaca

• Arritmia: Cuando se detectan anomalías en el ritmo o en la regularidad de las pulsaciones

Medición del pulso: Se percibe ejerciendo una ligera presión sobre la arteria hasta que se siente cada latido en las yemas de los dedos. Es fundamental no emplear el dedo pulgar al realizar la medición, ya que éste posee su propio latido y puede inducir a error. Asimismo, para medir correctamente la frecuencia cardiaca, lo ideal es que el usuario permanezca en reposo.

La arteria sobre la que se mide el pulso con mayor frecuencia es la arteria radial, ubicada en la cara anterior de la muñeca por debajo del dedo pulgar, si bien puede ser tomado en múltiples arterias tal y como se ilustra en la siguiente imagen:



3.5 RECOGIDA DE LAS MISMAS.

Una vez recogidas las diferentes constantes vitales deben quedar registradas en las gráficas que existan a tal efecto, haciendo constar los datos de filiación del usuario así como la fecha y la hora de recogida de las mismas. El sistema de registro o gráficas están incluidos en la historia del paciente. Contiene por escrito actuaciones profesionales que comprenden tanto datos antiguos como actuales, permitiendo ver la evolución en la situación del paciente.

Los parámetros que se registran respecto a las constantes vitales son:

- ✓ Temperatura. Se registra en color rojo y se va poniendo en la graduación de la temperatura que se determina. Cuando se toma otra temperatura, los puntos se unen mediante una línea.
- ✓ Tensión arterial. Se registra de color verde; se puede marcar con flechas y se une una línea vertical.
- ✓ Respiración. Se registra en color negro y de la misma forma que la temperatura. Cuando hay varios se unan por una línea.
- ✓ Pulso. Se registra en color azul y se configura por la unión de las distintas determinaciones.

Entre otros datos que se pueden consignar en los registros clínicos con el propósito de ofrecer una información lo más detallada posible al equipo médico. Entre estos datos se encuentran:

- Peso y talla
- Deposiciones
- Presión venosa central
- Drenajes
- Glucosa.

4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD Y PRIMEROS AUXILIOS

4.1 PRIMEROS AUXILIOS.

Son los cuidados inmediatos, provisionales y adecuados que los cuidadores deben prestar mientras esperan la asistencia del personal sanitario especializado.

Ante situaciones de riesgo, los cuidadores deben:

- Mantener la calma y actuar con decisión.
- Conocer y saber identificar las situaciones en las que es imprescindible solicitar ayuda urgente.
- Reconocer el lugar de los hechos y el estado general de la víctima

Su carácter inmediato radica en su potencialidad de ser la primera asistencia que esta víctima recibirá en una situación de emergencia, aspecto relevante en la atención a domicilio. Dadas las características en la prestación de la asistencia domiciliaria, el auxiliar de ayuda a domicilio debe estar familiarizado con las técnicas básicas de primeros auxilios, ya que en muchos casos, ante la aparición de una urgencia seremos los únicos profesionales que estemos presentes en ese momento, por lo que es fundamental saber actuar ante la aparición de las principales urgencias que pueden darse en el domicilio del usuario.

Los principios básicos del socorrismo son:

Proteger, Alertar y Socorrer (PAS).

1. Proteger: en primer lugar a él mismo y luego a la víctima. Podemos evitar nuevos accidentes, si señalizamos el lugar del accidente. Solo si hay peligro para el accidentado se de desplazará, manteniendo recto el eje cabeza-cuello- tronco.
2. Alertar: consiste en avisar, informar y pedir ayuda. Esto implica que, antes de iniciar cualquier maniobra de auxilio, el cuidador debe solicitar ayuda. La petición de ayuda ha de consistir en informar debidamente de lo ocurrido con el mayor detalle y con la mayor serenidad posible.
3. Socorrer: consiste en realizar una primera valoración primaria que consiste en reconocer los signos vitales de la persona evaluando el nivel de consciencia (consciente o inconsciente), la respiración (sí respira por sí misma) y la circulación (si tiene pulso) y posteriormente una valoración secundaria.

4.2 INTOXICACIONES.

Los accidentes por intoxicación más frecuentes en el hogar son los producidos por ingesta, inhalación o contacto de productos de limpieza, así como la ingesta de medicamentos o alimentos en mal estado. Una sustancia se considera tóxica cuando tomada en una concentración determinada es capaz de dañar el organismo.
Sustancias tóxicas son:

- Los medicamentos
- Los productos de limpieza de uso doméstico
- Humo de incendios.
- Intoxicaciones alimentarias

Las entradas de las sustancias tóxicas en el organismo pueden ser por vía:

- Digestiva
- Respiratoria
- Parenteral
- Contacto.

Las manifestaciones que puede presentar la víctima depende de:

- La naturaleza de la sustancia tóxica
- La vía de acceso de la sustancia tóxica
- La cantidad o concentración de las sustancias tóxicas.
- La sensibilidad de la persona afectada.

- Actuación ante una intoxicación
  1. Ante la sospecha de una intoxicación, es importante averiguar el tipo de tóxico, la concentración, vía de entrada, tiempo transcurrido…
  2. Se valora el estado de conciencia, el pulso y la respiración.
  3. En algunas intoxicaciones existe la posibilidad de administrar antídotos (son sustancias que neutralizan los efectos tóxicos)
  4. Está prohibido provocar el vómito en los siguientes casos:
     - Inconsciencia
     - Si convulsiona
     - Si hay dificultad respiratoria
     - Si la sustancia ingerida es: lejía, agua fuerte, disolventes.

- Actuación ante una intoxicación por gases

  Cuando se da una intoxicación por esta causa se dará oxigeno sin limitaciones, se trasladará a la persona semisentada. Se aflojará la ropa para facilitar la respiración, y se trasladará urgentemente a un Centro Hospitalario.

4.3 TRAUMATISMOS. VENDAJES E INMOVILIZACIONES.

4.3.1- TRAUMATISMOS

Los traumatismos en las extremidades producen lesiones en huesos, articulaciones, músculos y en órganos próximos.

Las lesiones mas corrientes son:

- Esguince: lesión de los ligamentos que unen una articulación, lesión que se produce tras un movimiento forzado. Los más comunes son el de tobillo o rodilla.
  Síntomas: dolor, inflamación e impotencia funcional.

  Procedimiento de actuación ante un esguince
  1. Aplicar hielo o compresas frías.
  2. Levantar la extremidad afectada y dejarla reposar.
  3. Inmovilizar la articulación
  4. No se debe aplicar pomadas hasta no visitar al médico para no enmascarar los síntomas.

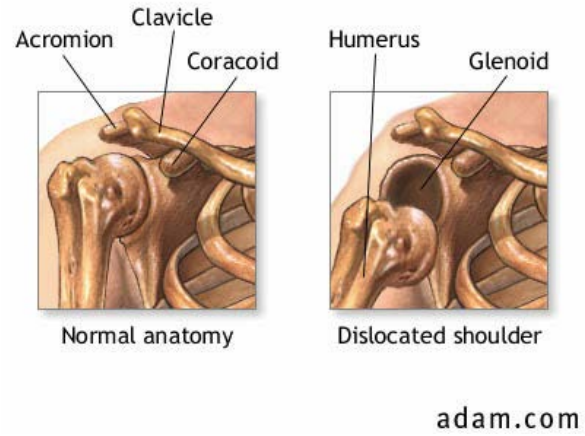
- Luxación: separación de los dos extremos que forman una articulación.
  Síntomas: dolor intenso, inflamación de la articulación, deformación de la articulación e impotencia funcional.

  Procedimiento de actuación ante una luxación
  1. Aplicar frío
  2. Inmovilizar y no intentar reducir la deformidad.
  3. Trasladar a la persona a un Centro Sanitario.

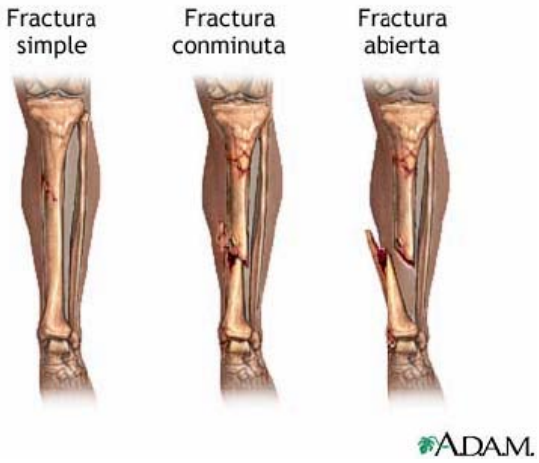
- Distensión: se produce cuando hay un estiramiento y desgarro de músculos o tendones al forzar demasiado el músculo.

  Síntomas: dolor, inflamación e impotencia funcional pero a nivel del músculo.

  Procedimiento de actuación ante una distensión
  1. Elevar la extremidad e inmovilizar la zona.
  2. Aplicar frío.
  3. No aplicar pomadas
  4. Trasladar a un Centro Sanitario a la persona.



- Fractura: se produce al romperse el hueso.



Síntomas: dolor intenso con inflamación que empieza en el punto de fractura y evoluciona al resto de la extremidad. Deformidad del miembro, impotencia funcional y enrojecimiento de la zona.

Procedimiento de actuación ante una fractura.

1. No movilizar a la persona si no es absolutamente necesario.
2. Inmovilización, si es una extremidad se inmoviliza incluyendo la articulación superior e inferior y se evitan los movimientos bruscos.
3. En el caso de fracturas abiertas, cubrir la zona con apósitos estériles y cohibir la hemorragia entes de inmovilizar.
4. No utilizar pomadas.
5. Traslado a un Centro Sanitario con la extremidad elevada, si es posible, en las mejores condiciones posibles.

- Traumatismos medulares: es una contusión en la columna vertebral que puede llevar una lesión en la médula.

Síntomas: dolor, parálisis, hormigueo en manos y dedos, perdida de sensibilidad, pérdida del control de esfínteres, alteración en la respiración...

Procedimiento de actuación ante un traumatismo medular

1. Colocar un collarín cervical.
2. Mover únicamente en bloque
3. Control permanente de las constantes vitales.
4. Nunca debe sentarse al herido, ni doblarle la espalda o el cuello

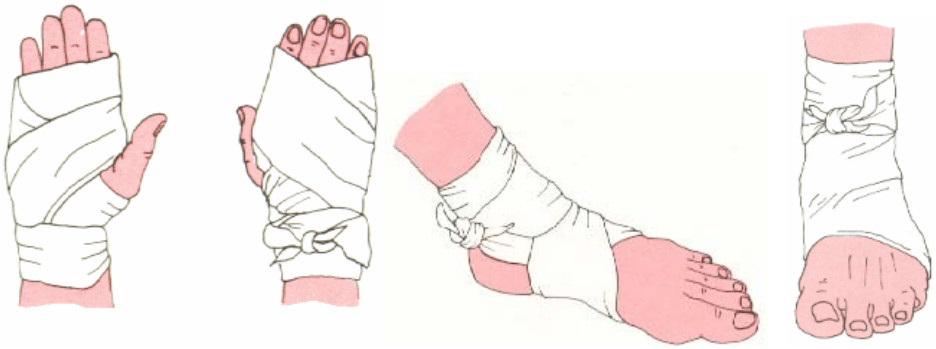
4.3.2- INMOVILIZACIONES

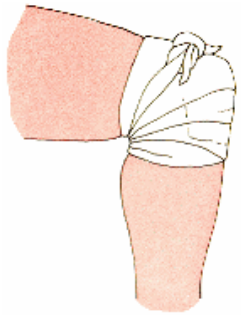
La inmovilización es un procedimiento que consiste en impedir el movimiento de un miembro fracturado hasta su traslado a un Centro Sanitario.
Para inmovilizar se utilizan: férulas, tablillas, almohadillas…. Y para inmovilizar se utilizan vendas, pañuelos,…..



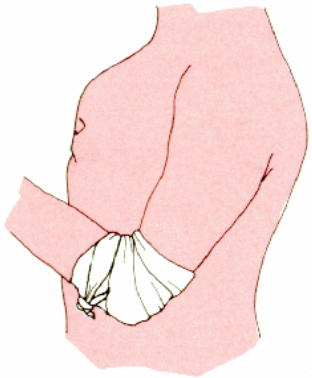
4.3.3- VENDAJES

Un vendaje consiste en envolver una zona corporal lesionada con una venda o similar. Su objetivo es inmovilizar una lesión, aplicar presión, sujetar férulas…..

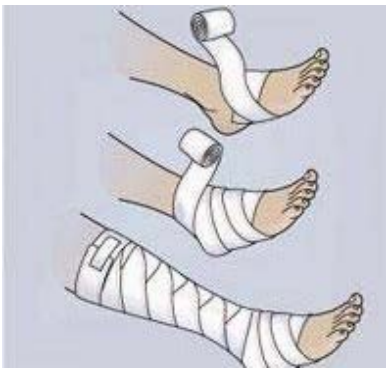




VENDAJE PARA RODILLA







4.4 TÉCNICAS DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR.

La reanimación cardiopulmonar es el conjunto de procedimientos que tienen como objetivo sustituir las funciones respiratoria y circulatoria hasta que se restablezca su funcionamiento. Consiste en aplicar de forma combinada las respiraciones y el masaje cardiaco. Aplicaremos, en el domicilio de los usuarios, la denominada RCP básica, que consiste en la aplicación de técnicas de reanimación sin ningún aparataje ni medicación. Para ello, se debe seguir una determinada secuencia de actuación, para un solo reanimador, y que a continuación se expone:

Protocolo de RCPB:

1. Confirmar la pérdida de conocimiento, sacudir suavemente los hombros.

2. Si la persona no responde se debe pedir ayuda urgentemente (112)



3. La posición de RCP, colocar a la víctima en decúbito supino apoyada sobre una superficie plana y firme.

4. Abrir la vía aérea. Es frecuente que la victima sufra una obstrucción de las vías aéreas, debido a la caída de la lengua o a la existencia de cuerpos extraños como una dentadura postiza.

   Con la maniobra frente-mentón conseguimos abrir la vía aérea, para saber si respira o no:



5. Comprobar si la víctima respira. Acercar su cara a la boca y nariz de la víctima dirigiendo la mirada al pecho. Con esta maniobra pretendemos VER-OIR-SENTIR



SI LA VÍCTIMA RESPIRA se colocará en POSICIÓN LATERAL DE SEGURIDAD y después se llamará al 112.
Con esta posición mantenemos la vía aérea libre por si vomita.

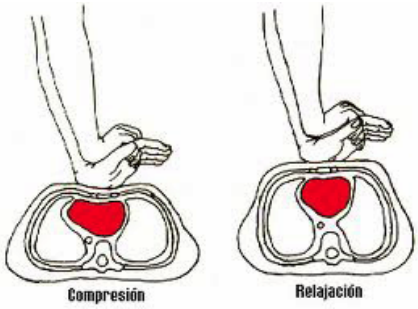


SI LA VÍCTIMA NO RESPIRA:

6. Se inicia masaje cardiaco (compresiones torácicas). El masaje cardiaco se realiza sobre la mitad inferior del esternón. Después de 30 compresiones torácicas, se intenta dos ventilaciones (30 / 2).



7. No se valora la comprobación de pulsos en ningún momento, sólo signos de recuperación. La toma de pulsos sólo será realizada por personal sanitario.

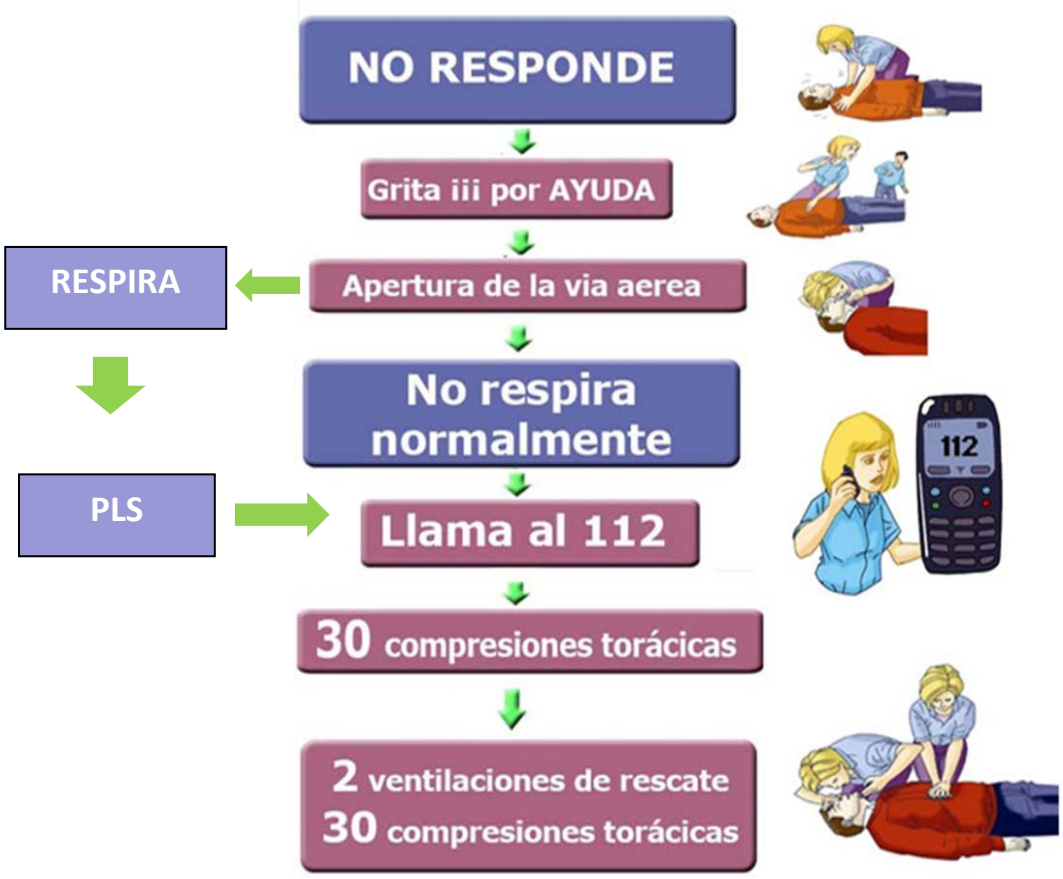


8. Sincronización compresiones/ventilación. Se realizan 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones.

Una vez iniciada la RCP no se comprobarán pulsos, ni respiraciones, y no nos detendremos hasta:

- La llegada de un Soporte Vital Avanzado
- Que la víctima comience a moverse
- Que el reanimador se canse

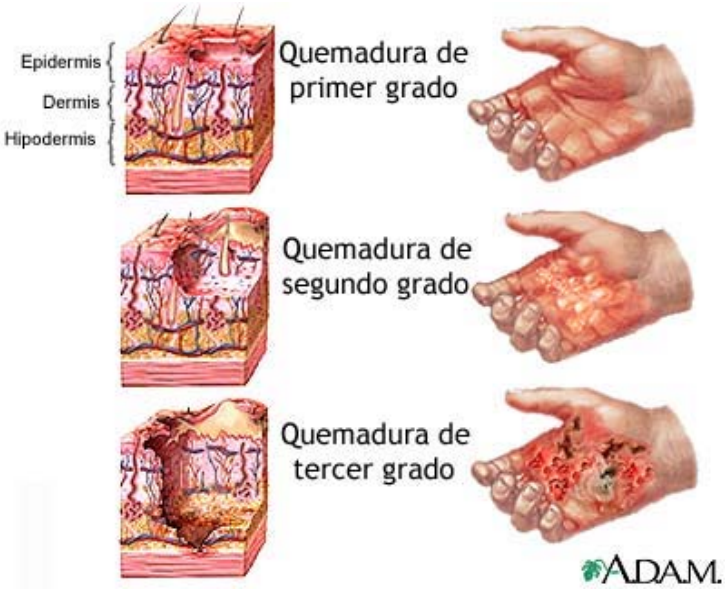

Utilice el peso de su cuerpo para hacer la compresión.
Mantenga la espalda recta.
BRAZOS RECTOS
Arrodillese a un lado de la víctima.
TALON DE LA MANO Sobre el Esternón.


NO RESPONDE
Grita iii por AYUDA
RESPIRA
Apertura de la via aerea
No respira normalmente
PLS
Llama al 112
112
30 compresiones torácicas
2 ventilaciones de rescate
30 compresiones torácicas

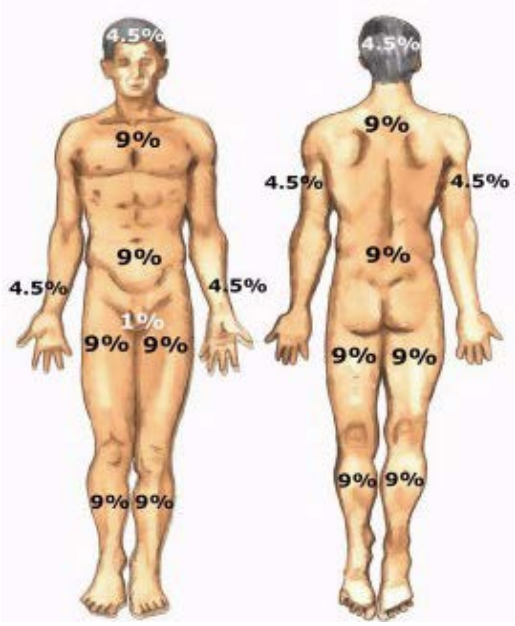
4.5 QUEMADURAS.

En el hogar las quemaduras suelen producirse generalmente por contacto con líquidos muy calientes (agua, café, aceite), con el fuego (cocinas, calentadores, estufas) o con objetos a temperaturas elevadas (planchas, hornos, sartenes…)
Las quemaduras son lesiones de los tejidos causadas por calor, electricidad, radiaciones.
Se clasifican:

- Quemaduras de primer grado: afectan a la epidermis (enrojecimiento)
- Quemaduras de segundo grado: afectan a la dermis (ampollas)
- Quemaduras de tercer grado: afectan a capas más profundas. Llegando al músculo, a los nervios y a los vasos sanguíneos. En estas no hay dolor, porque las terminaciones nerviosas han sido destruidas.



Según la extensión se clasifican según la regla de los nueve, dividiendo el cuerpo en partes ó múltiplos de 9.



- Actuación ante una quemadura leve

1. Se enfría rápidamente en el chorro con agua fría.
2. Se cubre la zona con apósitos estériles.

- **Actuación ante una quemadura grave**

LLAMAR AL 112.

1. **Neutralizar la fuente de calor (si es posible)**
2. **Valoración de la victima y la quemadura.**
3. **Vigilar las constantes vitales.**
4. **Enfriar la quemadura con agua fría, sin aplicar el chorro directamente sobre la quemadura.**
5. **Se quita la ropa al accidentado exceptuando la adherida a la piel.**
6. **No pinchar las ampollas.**
7. **Cubrir la zona quemada con apósitos estériles.**
8. **Llevar a un Centro Hospitalario.**

Observaciones

- Nunca se debe pinchar una ampolla
- Nunca debe correr una persona con llamas. Intentar cubrir con una manta.
- Nunca administrar antisépticos colorados.

- Nunca se vendarán dos superficies quemadas juntas.

4.6 HERIDAS Y HEMORRAGIAS.

Una herida es la pérdida de continuidad en la piel, lo que se denomina “solución de continuidad”, secundaria a un traumatismo. Como consecuencia de esta “agresión” existe el riesgo de infección y posibilidad de lesiones en órganos o tejidos adyacentes: músculos, nervios, vasos sanguíneos… El peligro más inmediato es la hemorragia: Es la salida de sangre fuera de los vasos sanguíneos. La sangre sale al exterior de una herida visible.

Según la procedencia de la sangre se pueden clasificar en:

• Arterial: procede de una arteria. Es una hemorragia peligrosa, la sangre es roja y sale a golpes coincidiendo con el pulso.
• Venosa: procede de una vena. La sangre es menos roja y sale de forma continua.
• Capilar: existen pequeños puntos sangrantes. También se llama hemorragia en sábana.

- **Actuación ante una hemorragia externa**

1. **LLAMAR AL 112**
2. **Se realiza una compresión directa sobre la zona sangrante.**
3. **Se eleva la extremidad afectada (pie, brazo)**
4. **Se comprime o presiona en la zona**

- Epistaxis

1. Tranquilizar al paciente.
2. Comprimir con el dedo índice el ala de la nariz de la fosa nasal presionando sobre el tabique nasal.
3. Si pasados 3 ó 4 minutos no cesa, se realiza un taponamiento anterior introduciendo una gasa con una solución coagulante.
4. Si no cesa a un Centro Hospitalario.

4.7 BOTIQUÍN DE URGENCIAS.

El botiquín es un recurso básico para las personas que atienden en un primer momento a una víctima. Debe existir un botiquín en todos los lugares donde haya concentración de personas.

4.7.1. Recomendaciones generales

• El botiquín debe estar en un lugar fresco y seco.
• El botiquín no tendrá cerradura para facilitar el acceso.
• Los envases de la medicación deben permanecer bien cerrados.
• El material dentro del botiquín estará ordenado y etiquetado
• El contenido del botiquín será revisado una vez al año por lo menos.
• Al desechar los medicamentos hazlo en contenedores a tal efecto en las farmacias.

4.7.2. Elementos esenciales

Los elementos esenciales de un botiquín de primeros auxilios se pueden clasificar así:

- Antisépticos: son productos o sustancias cuyo objetivo es la prevención de la infección. Ej. Povidona yodada, clorhexidina, alcohol al 70%, suero fisiológico, y jabón.

- Material para curas: se utiliza para controlar hemorragias limpiar, cubrir heridas o quemaduras, para prevenir la contaminación e infección. Ej. Gasas, compresas, apósitos, vendas, depresores linguales, esparadrapo, algodón

- Instrumental y elementos adicionales: guantes desechables, pinzas, tijeras, termómetro, pañuelos desechables, cuchillas de afeitar, bolsas de plástico, vasos desechables, lista de teléfonos de emergencias y manual o folleto de Primeros Auxilios.

- Medicamentos: el botiquín contendrá principalmente analgésicos y antiinflamatorios. Ej.: aspirina, nolotil, gelocatil, termalgin, ibuprofeno, espidifen neobrufén, fastúm (pomada)……

4.8 CONSULTAS A DISTANCIA.

Dadas las circunstancias habituales del desempeño laboral en el domicilio del usuario, pueden surgir ocasiones en las que sea preciso la consulta a distancia con un profesional de referencia, bien para ayudarnos a aclarar determinadas dudas, o para recibir pautas de actuación necesarias…
Se recomienda tener a mano el teléfono del centro de atención primaria del usuario para que podamos contactar con su médico o enfermera, ya que ellos tienen la historia sanitaria y nos pueden indicar las pautas necesarias a seguir.
También puede ser necesaria la consulta con el coordinador/a del servicio, ante la aparición de determinadas necesidades en la atención de nuestros usuarios, así como en determinadas circunstancias relacionadas con nuestra seguridad o actuación profesional.

Cuando la situación que tenemos delante es demasiado aparatosa o se escapa de nuestros conocimientos debemos insistir en el 112 para que los especialistas que allí trabajan nos asesoren en la distancia y podamos ir aplicando los primeros auxilios mientras esperamos a la llegada de los servicios de emergencia.

4.9 PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL ENTORNO DE LA PERSONA DEPENDIENTE.

Los riesgos más habituales en los pacientes ancianos son las caídas y/o las pérdidas de conocimiento durante las movilizaciones y los desplazamientos.

- Las personas del entorno de un anciano con tendencia a caerse, han de hacer lo imposible para que no se produzcan: Las caídas se pueden prevenir.

- En la cocina, no debe dejarse el suelo mojado o con agua derramada, una buena iluminación, los armarios y utensilios para cocinar serán de fácil acceso, para impedir el uso de taburetes o escaleras para acceder a coger los platos, por ejemplo.

- El baño es conveniente adecuarlo a sus limitaciones y/o necesidades físicas.

- En el resto de la casa evitar los juguetes desperdigados por el suelo o tapados por alfombras, fijar las alfombras con redes de goma antideslizantes, o eliminarlas si su fijación es imposible. Conviene evitar los suelos muy pulimentados y resbaladizos, asó como una adecuada iluminación para que el anciano pueda ver por donde anda.

- En el exterior de la casa recordarle que, al bajar las escaleras deberá agarrarse siempre a la barandilla o pasamanos, si no existieran éstas se agarrará del brazo de alguna persona o ponerse por delante.

- Durante la movilización: Intentar que se levante muy despacio y en varios movimientos. Desde la posición de tumbado, pasar a la de sentado y una vez seguro de no marearse, levantarse. Evitar los movimientos bruscos que pueden hacer perder el equilibrio fácilmente.

- Evitar utilizar sillas o muebles para alcanzar objetos altos en vez de escaleras apropiadas.

- Las puertas, balcones, ventanas que den acceso sobre zonas de riesgo deben disponer de un sistema de bloqueo que impida su apertura a los niños.

- No sobrecargar los enchufes con demasiados aparatos.

- No dejar cocinando en el fuego nada.

- Limpiar periódicamente los filtros de la campana.

- Evitar corrientes de aire que pudieran apagar el gas, especialmente si estamos en otra habitación.

4.10 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN.

Existe una máxima en socorrismo que dice: “Ningún socorrista muerto o herido es capaz de socorrer” por lo que se debe hacer especial atención a la AUTOPROTECCIÓN en todos los casos de emergencias

Prevención de lesiones músculo-esqueléticas:
Se atenderán las pautas de ergonomía y mecánica corporal indicadas anteriormente.

Manipulación de bolsas de orina:
-Se recomienda utilizar bolsas con válvula de vaciado, en caso contrario, si es preciso vaciarlas, se deberá utilizar prendas de protección contra salpicaduras que protejan el cuerpo, cara y manos.
-Nunca se elevarán por encima del nivel de la vejiga.
-Nunca se dejarán por los suelos.

Precauciones con usuarios con diarrea infecciosa, infecciones enterovirales, gastroenteritis, hepatitis A)
-Utilizar guantes de un solo uso.
-Realizar el personal de las manos antes de realizar cualquier maniobra con el enfermo.
-Utilizar bata ante la posibilidad de ensuciarse.

Uso de guantes:
-Generalmente de látex, siempre que podamos entrar en contacto con la sangre, líquidos corporales o mucosas del paciente.
-Al igual que si tenemos arañazos o pequeñas heridas en las manos, también deberemos utilizar guantes.
-siempre que se manipulen objetos o superficies contaminadas con sangre o fluidos.
-Siempre que se perforen, rompan o para atender a usuarios distintos, los guantes deben cambiarse.
- Se usarán siempre durante la manipulación de material cortante o punzante.

4.11 ATENCIÓN ESPECIAL A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

Al tratar con usuarios que en ocasiones presentan infecciones y/o enfermedades crónicas, los profesionales conviven a diario con multitud de microorganismos presentes en el ambiente del hogar. Por esta razón, y sin que necesariamente el propio trabajador desarrolle una enfermedad infecciosa, puede convertirse en un vehículo transmisor de microorganismos.
Para evitar esto se utilizan los métodos barrera (guantes, calzas, batas, etc.), que no sólo sirven para evitar el riesgo de infección y contagio de los propios trabajadores, sino también para prevenir el riesgo de transmisión de infecciones del personal a los usuarios de la institución.

- Utilizar guantes desechables.
- Proceder al lavado de manos antiséptico tras cada manipulación,
- Emplear ropa de seguridad si es necesario (batas, calzas, gorros, gafas y mascarillas).
- Usar protección ocular en caso de riesgo de salpicaduras.
- Manipular cuidadosamente todo el material.
- Clasificar y separar el material punzante y cortante del resto.
- Disponer de suelos y calzado antideslizantes.
- Evitar la mezcla de detergentes y desinfectantes..
- Cumplir un reconocimiento médico anual por parte del servicio de medicina preventiva del centro o por el servicio de prevención de riesgos laborales.
- Seguir una adecuada vacunación.

Mejorar las actitudes posturales:

- Mejorar nuestra higiene postural significa:
  - Tener una disposición y alcance adecuados de los elementos que nos rodean y utilizamos en la zona de trabajo. Hay que determinar la distancia óptima de manipulación en función de la mayor o menor altura de la persona.
  - Adecuación de la altura de la superficie de trabajo según sea la naturaleza del mismo, el grado de precisión necesario y el requerimiento de la fuerza.
  - Colocarnos correctamente, según cada ocasión y necesidad.
  - Aprender a movernos convenientemente.
  - Trabajar con seguridad, conocer gestos y posturas peligrosos. Reconocer la exigencia de cada tarea para poder determinar su duración, intensidad y dificultad.
  - Prevenir problemas de salud
  - Economizar esfuerzos físicos.

Al levantar pesos:

- Levantaremos pesos con las piernas, no con la espalda, poniéndonos de cuclillas y doblando las rodillas. Nunca nos agacharemos con las piernas rectas.
- No debemos girar o inclinar el trnco mientras se levanta una carga pesada. Evitamos daños sobre el disco y las articulaciones.
- Evitaremos levantar o alcanzar objetos por encima de los hombros.
- Cuando la carga sea pesada buscaremos ayuda.
- Siempre es preferible empujar que arrastrar el objeto.
- Mantener siempre los pies firmes y separados.
- No realizar movimientos bruscos queriendo aprovechar la inercia del cuerpo.